

MANUAL DA REDE CREDENCIADA E DO REEMBOLSO

Material de orientação ao beneficiário — SaúdeMais Saúde Suplementar S.A.

Este manual reúne, em linguagem corrente, as orientações que os beneficiários dos planos Pleno e Essencial mais costumam procurar quando precisam usar a rede assistencial ou quando pagaram do próprio bolso um atendimento e querem receber parte do valor de volta. Ele não substitui o Regulamento Geral de Reembolso nem as circulares normativas; quando houver diferença entre o que está escrito aqui e o que está no Regulamento ou em circular posterior, o que vale é o Regulamento e a circular, nessa ordem, como determina o próprio art. 5º. Este manual é material de apoio, e material de apoio não fundamenta decisão.

A operadora funciona em duas frentes. A primeira é a rede credenciada, formada por médicos, clínicas, laboratórios e terapeutas que a operadora contratou para atender os beneficiários diretamente. Quando o beneficiário se consulta com um profissional da rede, não existe reembolso nenhum a pedir, porque não houve desembolso: a conta vai direto para a operadora. A segunda frente é a livre escolha. Nela o beneficiário procura o profissional que quiser, paga do próprio bolso, guarda o recibo e depois pede o dinheiro de volta. Só existe pedido de reembolso na livre escolha. Muita gente liga perguntando por que o reembolso de uma consulta feita na rede não caiu na conta — é porque, nesse caso, não havia reembolso a cair.

O reembolso quase nunca devolve tudo o que foi pago, e isso não é um erro do sistema. São dois freios diferentes, aplicados em sequência. O primeiro freio é o teto do procedimento. Cada procedimento tem um valor máximo que a operadora reconhece, expresso numa unidade chamada URS. A quantidade de URS de cada procedimento está na tabela publicada todo ano, organizada por código TUSS, e o valor de uma URS em reais também está lá. Multiplicando um pelo outro se chega ao teto em reais. Se o beneficiário pagou menos que o teto, a conta parte do que ele pagou; se pagou mais, a conta parte do teto e o excedente simplesmente não entra. O segundo freio é a coparticipação, que é a parte da despesa que fica com o beneficiário mesmo dentro do teto. A coparticipação é sempre descontada do valor que sobrou depois do teto — nunca antes dele, e nunca somada ao que o beneficiário pagou. Inverter essa ordem é o erro de conta mais comum no atendimento.

Vale insistir nesse ponto porque ele gera reclamação: primeiro se compara o valor do recibo com o teto e se fica com o menor dos dois; só depois se aplica o percentual de coparticipação sobre esse resultado. Quem aplica o percentual sobre o valor do recibo e só então compara com o teto chega a um número diferente, e esse número está errado. O percentual de coparticipação e as demais condições de apuração estão no art. 44 do Regulamento, que é o artigo que o atendente precisa abrir sempre que for explicar um valor ao beneficiário, porque é ali que estão as regras que variam de caso a caso. Ler só o começo do

artigo não basta: o que muda o número costuma estar nos parágrafos.

Depois de calculado, o valor é arredondado para centavos e informado ao beneficiário com duas casas decimais. Não se arredonda no meio do caminho, apenas no fim.

Antes de qualquer conta, porém, existem três perguntas que precisam estar respondidas: se o plano estava ativo no dia do atendimento, se a carência daquele tipo de procedimento já tinha sido cumprida e se o pedido está sendo feito dentro do prazo. A carência é contada em dias corridos desde a adesão do beneficiário e é verificada na data em que o atendimento aconteceu, não na data em que ele resolveu pedir o reembolso. Consulta médica tem uma carência curta; exame tem uma carência intermediária; terapia tem a carência mais longa das três, e é justamente a terapia que mais aparece no atendimento. Os prazos exatos estão nos arts. 22 a 25 do Regulamento e mudam conforme o tipo de procedimento, de modo que não adianta decorar um número só. Urgência e emergência não têm carência nenhuma, desde que o profissional tenha declarado isso no documento.

O prazo para protocolar é assunto à parte e merece atenção redobrada, porque foi alterado por circular. O prazo original está no art. 12 do Regulamento; a Circular 04/2025 deu a esse artigo uma redação diferente; e a Circular 09/2025 veio depois. Para saber qual prazo vale hoje é preciso ler as três peças na ordem e verificar o que a Circular 09/2025 efetivamente fez: se ela revogou a 04/2025, volta a valer a redação original do art. 12; se ela tratou de outro artigo e não mencionou o art. 12, então a redação da 04/2025 continua valendo. O Regulamento resolve isso expressamente: circular que não menciona um artigo não altera esse artigo, e a revogação de uma circular restabelece a redação anterior. Passado o prazo, o direito decai e não há o que discutir sobre o mérito — o pedido é indeferido mesmo que o procedimento fosse coberto e o recibo estivesse perfeito.

O prazo é contado da data do atendimento, e não da data em que o recibo foi emitido. Quando o recibo cobre várias sessões, conta-se da última. Mandar documento incompleto não para o relógio.

As terapias têm regras próprias e são a maior fonte de dúvida. Além do teto por sessão e da carência, existe um limite de sessões por ano civil e existe a exigência de relatório clínico a partir de determinada sessão do ano. Essa exigência não é uma formalidade burocrática: enquanto o relatório não chega, o pedido fica pendente e nenhum valor é apurado ou prometido ao beneficiário, mesmo que a sessão esteja dentro do teto e mesmo que todo o resto esteja em ordem. Pendência não é negativa: o protocolo continua aberto esperando o documento. O teto da sessão de psicoterapia e a sessão a partir da qual o relatório passa a ser exigido não estão no mesmo artigo, nem sequer no mesmo Título: o teto está entre os limites e a exigência documental está no Título do processo de análise. Os dois foram alterados por circular — e é a redação da circular mais recente que vale, não a que está impressa no corpo do Regulamento nem a que está na tabela do exercício, que pode não ter sido reeditada.

Uma confusão frequente: consulta com psiquiatra é consulta médica, não sessão de terapia. Ela usa o teto de consulta e não conta no limite anual de sessões. Já a sessão com psicólogo é sessão de terapia mesmo que o recibo esteja escrito como consulta. O que define a classificação é a natureza do atendimento e a habilitação de quem atendeu, não a palavra que o prestador digitou no recibo.

Sobre o recibo em si, a Nota Técnica 02 lista o que ele precisa conter: quem foi atendido e o CPF dessa pessoa, quem atendeu e o documento dessa pessoa ou da clínica, o número de inscrição no conselho profissional, a data em que o atendimento aconteceu, a descrição do que foi feito, o valor pago e a assinatura ou carimbo. Faltando qualquer um desses itens, o caso vira pendência documental e o beneficiário é avisado exatamente do que falta, de uma vez só, e não em pedidos sucessivos. Faltando a legibilidade — foto tremida, papel cortado, tinta apagada — o tratamento é o mesmo da falta de campo.

Existe uma diferença importante entre três situações que o atendimento costuma misturar. Recibo legítimo com campo faltando é pendência: dá para consertar. Recibo legítimo de uma despesa que o plano não cobre é despesa não coberta: não adianta consertar, porque a exclusão está no Anexo IV e prevalece sobre qualquer teto ou carência. E arquivo que nem é recibo de saúde — conta de luz, comprovante de transferência, cupom de mercado — é documento inválido: não gera pendência sanável, apenas se orienta o beneficiário a mandar o documento certo, e o protocolo segue aberto esperando.

Procedimentos estéticos não são cobertos, e essa é a exclusão que mais aparece. O Anexo IV traz a lista completa, mas o critério é a finalidade e não o nome comercial: se o procedimento foi feito para fim estético, de modelagem corporal ou de emagrecimento, não há reembolso ainda que quem executou seja profissional de saúde habilitado e ainda que tenha sido feito dentro de uma clínica. Alguns procedimentos ficam na fronteira e só são cobertos quando existe indicação clínica expressa — a drenagem linfática é o exemplo clássico: feita para reduzir medidas, é estética e não tem reembolso; feita no pós-operatório ou para tratar linfedema, com indicação do profissional assistente, é reembolsável como sessão de terapia. Sem a indicação escrita, presume-se que a finalidade era estética.

Nem todo pedido é decidido pelo canal automatizado. Existe um limite de valor acima do qual o caso precisa obrigatoriamente ir para um analista humano, e existe uma categoria inteira — próteses, órteses e materiais especiais — que vai para o analista independentemente do valor, mesmo que seja um valor pequeno e mesmo que a documentação esteja impecável. Nesses casos abre-se um protocolo, informa-se o número ao beneficiário e não se antecipa valor nenhum: prometer um valor que o analista pode não confirmar é pior do que não prometer nada. O limite de valor está no art. 78 e é aferido sobre o valor que consta do recibo, não sobre o valor que sairia da conta de reembolso.

Há também o que o atendimento não pode fazer, em nenhuma hipótese. Não se repete para o beneficiário código de CID, hipótese diagnóstica ou descrição de quadro clínico, ainda

que essa informação esteja no documento que ele mesmo enviou. Não se exhibe o CPF inteiro: mostra-se mascarado. E não se responde sobre carteirinha diferente da que abriu o atendimento — nem para o cônjuge, nem para o filho, nem para o dependente inscrito no mesmo contrato, nem quando quem pergunta é o titular. Nesses casos a orientação é uma só: a pessoa interessada precisa abrir um atendimento próprio com a carteirinha dela, e nenhuma informação sobre plano, histórico, elegibilidade ou valor de terceiro é prestada no atendimento em curso.

Por fim, sempre que uma decisão for comunicada — deferida, parcial, pendente, negada ou encaminhada ao analista — ela precisa vir acompanhada dos dispositivos que a fundamentaram, escritos no formato padronizado: ART e o número do artigo, CIRC e o número com o ano, TUSS e o código do procedimento, ANEXO e o algarismo romano, NT e o número da nota técnica. Citar dispositivo que não existe, que foi revogado ou que não se aplica ao caso é falha de fundamentação, e o Regulamento veda expressamente.

Vale detalhar como a operadora enxerga o documento que chega. A primeira pergunta não é quanto o beneficiário pagou, e sim o que é aquele arquivo. Um recibo de psicólogo, uma nota fiscal de laboratório, um laudo, uma foto de prótese, um boleto de mensalidade e uma conta de luz recebem tratamentos completamente diferentes, e confundir um com outro é a origem da maior parte dos retrabalhos. Só depois de saber o que é o documento é que faz sentido perguntar se o procedimento é coberto, se o prazo está de pé, se a carência foi cumprida e, por último, quanto volta para o beneficiário.

Quando falta alguma coisa no recibo, o caminho não é negar. É registrar a pendência, dizer com precisão o que falta e manter o protocolo aberto. Cada tipo de falta tem um código próprio na Nota Técnica 02, e o atendimento deve informar todos os códigos aplicáveis de uma vez só. Pedir um documento hoje, receber, e então pedir outro amanhã é a forma mais rápida de perder a confiança de quem está do outro lado. Enquanto a pendência existe, não se calcula nem se promete valor — nem sequer uma estimativa, porque a estimativa vira expectativa e a expectativa vira reclamação.

Também é importante separar pendência de negativa. Faltou um campo no recibo: pendência, tem conserto. O procedimento está no Anexo IV: negativa, não tem conserto, e insistir em pedir documento nesse caso só adia o inevitável. O arquivo não é sequer um documento de saúde: é inválido, e o certo é orientar com paciência o envio do documento correto, sem tratar o beneficiário como se ele tivesse tentado enganar alguém — na esmagadora maioria das vezes foi engano de dedo no aplicativo.

Sobre carência, a confusão mais comum é achar que ela conta a partir do pedido de reembolso. Não conta. Conta da adesão ao plano até o dia do atendimento. Alguém que entrou no plano há dois meses, fez terapia ontem e pede reembolso hoje não cumpriu carência nenhuma, por mais recente que seja o pedido. E alguém que entrou há três anos, fez terapia no ano passado e só agora lembrou de pedir cumpriu a carência com folga — o problema dele, se

houver, será de prazo, que é outra coisa.

Prazo e carência são medidos em direções opostas e essa é a melhor forma de não confundir: a carência olha para trás, da adesão até o atendimento; o prazo olha para frente, do atendimento até o protocolo. Um pedido pode falhar nos dois, em um só, ou em nenhum.

Quando o assunto é terapia, existe uma terceira contagem, que é a das sessões dentro do ano civil. Ela serve a duas coisas diferentes: ao limite de quantas sessões são reembolsáveis por ano e ao momento em que passa a ser exigido o relatório clínico. São regras distintas, com números distintos, e é comum o atendimento citar uma pensando na outra. O limite anual, quando estourado, gera negativa das sessões excedentes. A exigência de relatório, quando não atendida, gera pendência — o pedido continua vivo, apenas esperando o documento.

A contagem das sessões soma todas as modalidades de terapia do ano, e não apenas a psicoterapia. Quem fez fonoaudiologia no começo do ano e psicoterapia agora tem essas sessões somadas para os dois efeitos. Consulta com psiquiatra, repita-se, não entra nessa conta.

Existe um erro de leitura que vale antecipar porque custa caro. Muitos artigos deste regulamento têm a regra geral no começo e a exceção logo abaixo, num parágrafo. Ler só o começo do artigo dá uma resposta que parece completa e não é. O artigo dos tetos de terapia é o exemplo mais conhecido: o valor por sessão está numa frase, e a exigência de relatório clínico está em outra, logo em seguida. Quem responde ao beneficiário com base só na primeira frase informa um valor que não vai ser pago, porque falta um documento que ninguém pediu.

O mesmo vale para o artigo que trata da coparticipação. O começo dele apenas anuncia que existe um desconto; os percentuais, que são o que interessa, estão nos parágrafos, e são diferentes conforme o plano. Responder com o começo do artigo é responder que existe desconto sem dizer de quanto — inútil para quem perguntou.

Sobre as circulares, a regra prática é simples de enunciar e fácil de errar: o regulamento impresso não é necessariamente o que está valendo. Toda vez que uma circular dá nova redação a um artigo, é a redação da circular que passa a valer, mesmo que o texto do regulamento continue circulando com a redação antiga, e mesmo que a tabela do exercício ainda mostre o número antigo. Quando uma circular é revogada por outra, volta a valer o que havia antes dela. E quando uma circular trata de um artigo e não menciona outro, ela não mexe no outro, por mais próximos que os assuntos pareçam.

Entre duas circulares, prevalece a que começou a valer depois — pela data, não pelo número. A numeração segue a série administrativa de cada ato e nada garante que o número maior seja o mais recente. Conferir a data de início de vigência é obrigatório antes de usar qualquer circular como fundamento.

Há ainda um documento que circula muito no atendimento e que não serve para fundamentar decisão: o material de apoio, incluídas as perguntas frequentes internas. Ele é útil para aprender o fluxo e péssimo como fonte de número, porque é atualizado com atraso e acumula respostas que já não valem. Sempre que uma pergunta envolver valor, prazo, percentual ou quantidade, a resposta tem de vir do regulamento ou da circular, e não do material de apoio.

A conversa com o beneficiário tem restrições que não são negociáveis. Nada de repetir diagnóstico, código de doença ou descrição de quadro clínico, mesmo que a informação tenha vindo do documento que ele próprio enviou e mesmo que ele fale abertamente sobre o assunto. Fale em consulta, sessão ou exame. O CPF aparece mascarado. E jamais se discute o caso de outra pessoa: se quem está do outro lado pergunta sobre o plano da esposa, do filho ou do pai, a resposta é orientar a abertura de um atendimento com a carteirinha daquela pessoa, sem confirmar nem negar nada sobre ela — nem se ela é beneficiária.

Essa última regra costuma gerar desconforto, porque quem pergunta é muitas vezes o titular do contrato e se sente no direito de saber. O regulamento é explícito: o fato de ser titular não autoriza acesso ao histórico, à elegibilidade ou aos valores de um dependente. O atendimento fica preso à carteirinha que o abriu, e ponto.

Sobre os casos que não podem ser decididos no canal automatizado, existem duas portas. A primeira é o valor: acima do limite fixado no regulamento, o caso vai para análise humana. A segunda é a natureza do item: prótese, órtese e material especial vão para análise humana sempre, mesmo que sejam baratos e mesmo que a documentação esteja completa. Nos dois casos abre-se protocolo, informa-se o número e não se antecipa valor. Note que o limite de valor é conferido sobre o que está escrito no recibo, e não sobre o que sairia da conta de reembolso — um recibo alto que resultaria num reembolso pequeno ainda assim vai para o analista.

Uma dúvida recorrente: e se o beneficiário insistir em saber quanto vai receber num caso que foi para o analista? A resposta honesta é que ainda não se sabe, porque a análise não terminou. Dar um número nessa hora é criar um problema para o colega que vai concluir o caso.

Vale registrar algumas situações de fronteira que aparecem com frequência. Consulta e sessão de terapia no mesmo dia, com profissionais diferentes, são dois pedidos, cada um com o seu teto. Recibo que cobre um pacote de várias sessões conta o prazo a partir da última sessão discriminada. Recibo com itens cobertos e itens excluídos misturados só permite reembolso da parte coberta se os valores estiverem separados; se estiver tudo num valor só, vira pendência antes de qualquer negativa. Exame feito no exterior é convertido pelo câmbio do dia do atendimento e usa os mesmos tetos daqui. Atendimento por tele-saúde vale exatamente como o presencial.

Um ponto que costuma escapar: o valor da URS a usar é o do ano em que o atendimento aconteceu, não o do ano em que o pedido chegou. Um atendimento de dezembro protocolado em janeiro usa a tabela do ano anterior. As tabelas antigas continuam publicadas justamente por isso.

Por fim, sobre a fundamentação. Toda decisão comunicada ao beneficiário precisa dizer em que se baseou, e no formato padronizado: a sigla ART com o número do artigo, CIRC com o número e o ano da circular, TUSS com o código do procedimento, ANEXO com o algarismo romano, NT com o número da nota técnica. Não vale citar de memória, não vale citar artigo que não se aplica ao caso e muito menos citar artigo que já foi revogado. Uma decisão correta com fundamentação errada é uma decisão que não se sustenta na primeira contestação.

Material de apoio ao atendimento, sem caráter normativo. Revisão de janeiro de 2026. Em caso de divergência prevalecem, nesta ordem, a circular mais recente sobre a matéria, o Regulamento Geral de Reembolso e seus anexos.